

Dr. Kacem Seif.

123 Lorem avenue,
Region, City 1023
Phone 123-456-7890

Cardiologie

CAT DEVANT IDM ST+

Rx

Traitement en urgence

- 1** 1 ère intention = angioplastie Primaire 1
- 2** 2 eme intention = Thrombolyse

✍ **La Thrombolyse : Comporte 2 Volets:**

- 1** Volet 1 : La dose de charge
- 2** Volet 2 : Fibrinolyse

✍ **La Fibrinolyse:**

- soit par : metalyse
- soit par : Acti-lyse

✍ **La dose de charge :**

- Clopidogrel : Plavix
- IEC
- Aspegic
- anti coagulation

Dr. Kacem Seif.

123 Lorem avenue,
Region, City 1023
Phone 123-456-7890

Cardiologie

Name

CAT DEVANT IDM ST+

Age

Address

Rx

✍ Bilan: obligatoire avant la thrombolyse :

- FNS
- TP
- TCK
- Urée / Créa

**🚨 on doit Calculer le débit de filtration
Rénale : pour Ajuster la dose de
l'énoxaparine : Lovenox**

✍ Le DFG normal > 30-120 mL/min

Ref/Re

Rx. No.

Signature

123 Lorem avenue,
Region, City 1023
Phone 123-456-7890

Cardiologie

CAT DEVANT IDM ST+

 $\mathbb{R}_x$

Selon l' Âge :

Si < 75 ans :

*** soit 4 cp a la fois: Si Coronarographie ou stenting Programmé dans un delai < 24 h**
*** soit 8cp à la fois: Si Coronarographie Ou stenting programmé dans un delai >24H**

Si > 75 ans : 1 seul cp Peros

 **IEC : Captopril**

Si TA > 180. = 02cp 50 mg.
Si TA > 130 = 01cp 50 mg
Si TA < 130. = 01 cp 25 mg

Page 103

Fig. Two

Sonaborn

Dr. Kacem Seif.

123 Lorem avenue,
Region, City 1023
Phone 123-456-7890

Cardiologie

Name

CAT DEVANT IDM ST+

ce

Address

Rx

 **Aspégic : 250 mg IVD**

 **Si non disponible :**

*** Soit Aspegic 100mg Peros**

*** Soit 1 Sachet de 100 mg de Peros**

Refila

Rx. No

Signature

Dr. Kacem Seif.

123 Lorem avenue,
Region, City 1023
Phone 123-456-7890

Cardiologie

Number

CAT DEVANT IDM ST+

de

Address

Rx

AntiCoagulation

★ Enoxaparine :

soit : lovenox
soit : varénox

Enoxaparine à dose 100 ui Kg

🔴 Example :

**patient 80 Kg donc La dose de Lovenox = $80 \times 100 \mu\text{i}$
= $8000 \mu\text{i}$ = 0.8mL == 0.3 en IVD et 0.5 en S/C**

**🔴🔴 NB important quelque soit la dose injectée de
Heparine , Il faut TjR diviser en 2 :**

- ★ 0,3mL IVD: dose-fixé**
- ★ Et le reste en S/C**

Refils

Rx. No

Signature



Dr. Kacem hadji seif قاسم حاجي سيف



@dr.kacem.seif



@dr...kacem.seif

URGENCES

Name

Arrêt cardiorespiratoire (ACR)

Date

Address

Rx

Le diagnostique est clinique

Arrêt :

Absence de réaction, patient inconscient



Cardiaque :

Absence de pouls carotidien ou fémoral



Respiratoire :

Absence de respiration spontanée



WATSON

3 choses à faire sur place :

- 1- Une alerte au samu
- 2- Le début de la réanimation cardio-pulmonaire
- 3- Noter l'heure de l'arrêt

Refils

Rx. No

Signature



Dr. Kacem hadji seif قاسم حاجي سيف



@dr.kacem.seif



@dr...kacem.seif

URGENCES

Name

Arrêt cardiorespiratoire (ACR)

Date

Address

Rx

Les étiologies

Cardiaques

SCA ST(+) : Infarctus du myocarde

Troubles du rythme

Troubles de la conduction

Tamponnade péricardique

Chez le sujet jeune : cardiomyopathie hypertrophique / Dysplasie arythmogène du ventricule droit

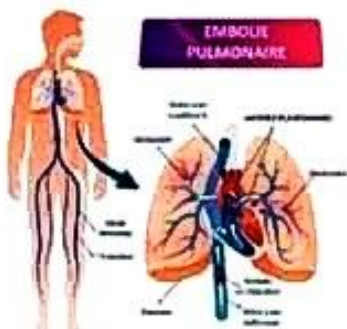
Générales Hypoxiques

Respiratoires: embolie pulmonaire / Pneumothorax compressif / détresse respiratoire

Métaboliques: hypo ou hyperkaliémie / acidose métabolique / hypothermie

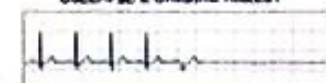
Toxiques: intoxication médicamenteuse (BB, digitaliques, etc: cf)

Neurologiques: état de mal épileptique / hémorragie méningée / AVC..



CARDIAC TAMPONADE

- HEMODYNAMICALLY UNSTABLE
↳ may develop CARDIOVASCULAR COLLAPSE & CARDIAC ARREST



- REQUIRE PROMPT RECOGNITION & TREATMENT w/ EMERGENT DRAINAGE of PERICARDIAL FLUID



Symptômes AVC

Quels sont les signes d'AVC ?



Les différents types d'AVC



Ref:is

Rx No

Signature



Dr. Kacem hadji seif قاسم حاجي سيف



@dr.kacem.seif



@dr...kacem.seif

URGENCES

Nome

Arrêt cardiorespiratoire (ACR)

Date

Address

Rx

Prise en charge

Réanimation cardio-pulmonaire de base " CAB "

Circulatoire :
Massage cardiaque

- Patient allongé sur un plan dur / talons des mains du sauveteur placés au centre du thorax / exerçant des pressions déprimant le thorax de -6 cm
- Alternances: 30 compressions puis 2 insufflations;
- Contrôle du pouls carotidien ou fémoral induit par les manoeuvres
- changement de personne si fatiguée



Airways :
Libération des voies aériennes

- Subluxation du maxillaire inférieur / hyperextension cervicale (sauf lésion rachidienne) / extraction des corps étrangers buccaux / manoeuvre de Heimlich: si notion de corps étranger laryngé



Breathing :
Ventilation

- par un insufflateur manuel et un masque ou par bouche-à-bouche
- Environ 6 insufflations/min avec une expiration passive afin d'éviter l'hyperventilation.



Refis

Rx. No

Signature



Dr. Kacem hadji seif قاسم حاجي سيف



@dr.kacem.seif



@dr...kacem.seif

URGENCES

Nome

Arrêt cardiorespiratoire (ACR)

Date

Address



Prise en charge

Réanimation cardio-pulmonaire médicalisé

- Poursuite de la réanimation cardiopulmonaire.
- Massage cardiaque externe.
- Ventilation : par une intubation orotrachéale , par un insufflateur manuel puis mécanique / O2 pur.

Électrocardioscope - défibrillateur.

- Analyse du rythme cardiaque:
FV (70%), TV, asystolie,
dissociation électromécanique
- Evaluation de l'indication de
CEE: Fibrillation ventriculaire,
Tachycardie ventriculaire
- Délivrance de CEE(choc
electrique externe) / énergie
initiale: 150-200 J/énergie
croissante en cas d'échec.



Ref:is



Adrénaline

- 1 mg IVD toutes les 4 minutes
(tous les 2 cycles de RCP)
- 1^{er} dose possible en
intra-osseux ou intratrachéal en
attendant l'abord vasculaire
- en cas d'asystolie, possible
augmentation des doses jusqu'à
5 mg/injection.



Amiodarone

- en cas de FV ou TV sans pouls
et résistantes à 3 CEE;
- AMIODARONE = 300 mg IVD
dans 20 cc de sérum
physiologique/ + 150 mg: si FV
persistante ou récidivante.



Signature



Dr. Kacem hadji seif قاسم حاجي سيف



@dr.kacem.seif



@dr...kacem.seif

URGENCES

Nome

Arrêt cardiorespiratoire (ACR)

Date

Address

Rx

Prise en charge Traitement étiologique

- **acidose métabolique ou hyperkaliémie sévères**: bicarbonate de sodium 84 %

- **hypovolémie** : expansion volémique au sérum physiologique (et transfusion en cas d'hémorragie);

- **hypothermie**: réchauffement;

- **intoxication médicamenteuse**: antidote/ alcalinisation/dialyse selon le toxique

- **IDM** : thrombolyse/ angioplastie;

- **EP** : thrombolyse;

- **pneumothorax compressif** : décompression à l'aiguille;

- **tamponnade** : ponction évacuatrice /expansion volémique/puis drainage chirurgical.



Ponction pleurale

Refils

Rx. No

Signature

Dr. Kacem Seif.

123 Lorem avenue,
Region, City 1023
Phone 123-456-7890

Gynécologie-Obstétrique

Name

Vulvo-vaginite à *Gardnerella vaginalis*

Date

Address

Rx

- Ce n'est pas une IST
- Un hôte normal de la flore vaginale, qui peut devenir pathogène, on parle alors de vaginose bactérienne

Dc clinique facile :

Leucorrhée abondante, grisâtre, et nauséabonde.

Dc de certitude :

- Test à la potasse positif (odeur de poisson pourri).
- PH vaginal alcalin.
- Au microscope : présence de Clue cells (cellules vaginales en amas, recouvertes de bactéries)

Traitement :

- TRICHOGIN (tinidazole) 500 mg : 4 cp en une prise.
- ZYRDOL-GYN (metronidazole) ovules 1 ovule le soir pendant 10 jours.

Refills

Rx. No.

Signature

Dr. Kacem Seif.

123 Lorem avenue,
Region, City 1023
Phone 123-456-7890

Gynécologie-Obstétrique

Name

Vulvovaginite à Chlamydia

Date

Address

Infection sexuellement transmissible (IST).

Clinique :

Rx

- La forme asymptomatique est la plus fréquente. Elle peut être découverte du fait d'une urétrite du partenaire
- Leucorrhées, jaunes ou blanches, parfois peu différentes en quantité des pertes physiologiques
- Cervicite avec glaire purulente

Examens Paracliniques :

- PCR Chlamydiae sur le prélèvement de l'endocol et l'ECBU
- Bilan IST (VIH 1 et 2 / VHB/VHC: TPHA/VDRL) +++ de la patiente et du partenaire

Traitement :

- ISTACYNE (doxycycline) 100mg cp: 1cp*2/j pendant 21 jours
- Abstinence sexuelle jusqu'à la guérison
- éducation/information sur les IST
- Traitement du ou des partenaire(s)

Refills

Rx. No.

Signature

Dr. Kacem Seif.

123 Lorem avenue,
Region, City 1023
Phone 123-456-7890

Gynécologie-Obstétrique

Name

Date

Vulvovaginite à gonocoques

Address

Infection sexuellement transmissible (IST).

Clinique :

Rx

Leucorrhée jaunâtre, purulentes, parfois associée à une dysurie.

- Urétrite ou skénite associée
- Cervicite avec glaire purulente

Rechercher :

- Une urétrite chez le partenaire .

Examens Paracliniques :

- Le diagnostic repose sur l'identification du germe sur la mise en culture des prélèvements vaginaux.
- Bilan IST +++ de la patiente et du partenaire

Traitement :

- CEFTAJECT I.M (ceftriaxone) 500mg injectable : 1inj en IM
- FARMODOXI (doxycycline) 100mg cp: 1cp*2/J pendant 7 jours

- Désormais, rapports sexuels protégés
- Abstinence sexuelle jusqu'à la guérison
- éducation/information sur les IST
- Traitement du ou des partenaire(s)

Refills

Rx. No.

Signature

Dr. Kacem Seif.

123 Lorem avenue,
Region, City 1023
Phone 123-456-7890

Gynécologie-Obstétrique

Name

Date

Vulvo-vaginite à *Trichomonas vaginalis*

Address

Infection sexuellement transmissible (IST).

Facteurs de risques :

Rx

- Alcalinisation vaginale (Toilette excessive avec du savon alcalin)
- Hypoestrogénie

Diagnostic :

- Leucorrhée verdâtre, nauséabonde, bulleuse
- Vulvo-vaginite ± Lésions de grattage
- Cervicite avec piqueté hémorragique, col rouge framboisé

Examens Paracliniques :

- Visualisation de protozoaires flagellés et de pyocytes à l'examen direct extemporané du prélèvement vaginal
- Bilan IST de la patiente et du/des partenaires

Traitement :

- Prescription pour les deux partenaires :
- TRICHOGIN (tinidazole) 500mg, 4 cp en une seule prise
- Chez la patiente, on adjoint :
- NIDAZOL (metronidazole) ovule : 1 ovule le soir pendant une semaine.
- Toilette avec savon acide
- Conseiller l'arrêt des rapports sexuels pendant une semaine.

Refills

Rx. No.

Signature

Dr. Kacem Seif.

123 Lorem avenue,
Region, City 1023
Phone 123-456-7890

Gynécologie-Obstétrique

Name

Date

Address

Vulvo-vaginite à candidat albicans

Rx

Vulvo-vaginite à Candida Albicans (mycose) n'est pas une maladie sexuellement transmissible, Le bilan IST est inutile.

Facteurs de risques

- Grossesse
- Ménopause
- diabète, immunodépression, hyperthyroïdie.
- ATBthérapie / Corticothérapie
- Pilule oestro-progestative / TTT progestatif
- TTT anticholinergique

Causes locales :

- Pantalon trop serré
- Sous-vêtements synthétiques
- Piscine
- Toilette excessive

Traitement

GYNO-PEVARYL (econazole) : 1 ovule renouvelable au 3e et au 6e jour.

PEVARYL (econazole) crème, 1 app matin et soir sur la vulve pendant 10 jours.

Diagnostic

Le Dc est clinique +++ ;

Tableau clinique :

Signes fonctionnels :

- Prurit
- Brûlures vulvaires
- dyspareunie

Examen clinique :

- Leucorrhée grumeuleuse et blanchâtre +++
- Vulvo-vaginite ± Lésions de grattage
- Pas de fièvre

Autres mesures

- Toilette intime au savon alcalin
- correction des facteurs de risque
- Rapports sexuels protégés jusqu'à la fin du TTT
- Traiter le partenaire par PEVARYL (econazole) solution spray si symptomatique (en cas de balanite) ou récidive.

Refills

Rx. No.

Signature

Dr. Kacem Seif.

123 Lorem avenue,
Region, City 1023
Phone 123-456-7890

Maladies Infectieuses

Name

Taeniasis

Address



R_x

Taeniasis

-Agent infectieux :

Taenia saginata et Taenia solium (= cysticercose) : Cestodes = vers segmentés et plats de plusieurs mètres

-Mode de contamination :

voie digestive (viande de bœuf pour saginata ou viande de porc pour la cysticercose)

Clinique :

-Souvent Asymptomatique

-Parfois douleurs abdominales, nausée, anorexie, urticaire

-Cysticercose humaine : grave, risque d'enkystement de larves dans les muscles, le cerveau (risque de crise convulsive) et les yeux

Diagnostic :

Présence d'anneaux dans les selles , les sous-vêtements ou à l'EPS (examen parasitologique des selles).

NFS : Eosinophilie normale ou modérément élevée

Cysticercose humaine : sérologie, fond d'œil, TDM cérébrale et radio des muscles à la recherche de calcifications

Traitement :

BILTRICIDE (praziquantel) : 10mg/kg en une seule prise

Refills

Rx. No.

Signature

Dr. Kacem Seif.

123 Lorem avenue,
Region, City 1023
Phone 123-456-7890



Maladies Infectieuses

Name

Ascariidose

Address

R_x

Ascariidose

1-Agent infectieux :

Ascaris lumbricoides ; Nématode : vers rond blanc rosé de 15 à 25 cm de long

**2-Mode de contamination :
voie digestive (eau ou aliments souillés)**

3-Clinique :

- Souvent Asymptomatique**
- Parfois dyspepsie**

4-Diagnostic :

EPS (examen parasitologique des selles) x 3 : présence d'oeufs ovales
NFS : Hyperéosinophilie

5-Traitement :

VERZOL (albendazole) 400mg cp ou 4% suspension buvable : 1 cp ou 1 cuillère mesure en une prise

Ou COMBANTRIN (pyrantel) 125mg cp ou sirop : 1cp ou une 1 cuillère mesure en une prise

- SPASFON (phloroglucinol) 80MG CP : 1 à 2cp*3/j

+Mesures préventives contre le péril fécal

Refills

Rx. No.

Signature

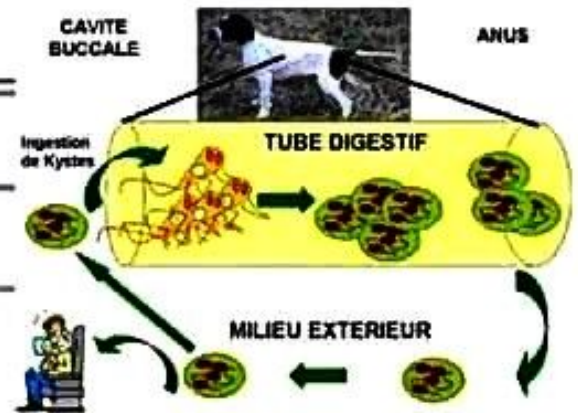
123 Lorem avenue,
Region, City 1023
Phone 123-456-7890

Närre

Address

 R_x

-EPS de contrôle à 1 mois



Results

Rx No. _____

Signature _____

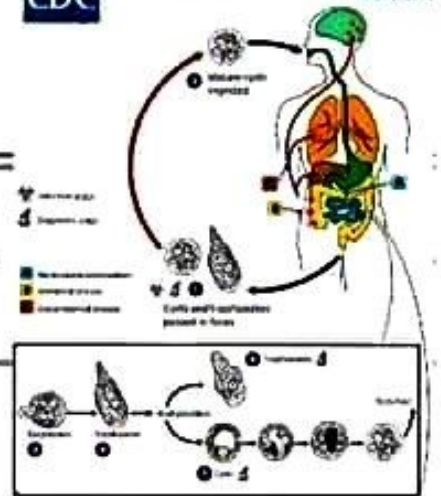
Dr. Kacem Seif.

123 Lorem avenue,
Region, City 1023
Phone 123-456-7890



Amoebiasis

ODPDx



Maladies Infectieuses

Name

Amoebiose

Address

Rx

1-Agent infectieux :

- Entamoeba histolytica = protozoaire
- Parasite du côlon humain , 2 formes :

Forme Trophozoite : forme végétative mobile et de multiplication

Forme Kystique : immobile, résistant aux traitements et responsable de la contamination

2-Mode de contamination :

Mains souillées, consommation d'eau ou d'aliments souillés

3-Clinique :

3-1-Amoebiose colique:

- Diarrhée subaiguë ou chronique, avec selles pâteuses ou glaireuses et douleurs abdominales
- Pas de fièvre ni d'AEG

3-2 -Amoebiose hépatique : fièvre à 38°C, hépatomégalie douloureuse

4-Diagnostic :

Amoebiose colique :

- NFS normale

- EPS (examen parasitologique des selles) 3j de suite : amibe mobile et hématophage
- Rectoscopie : ulcérations des muqueuses (en coups d'ongle)
- Si fièvre, faire COPROCULTURE pour recherche de shigelle

Amoebiose hépatique:

- Syndrome inflammatoire biologique
- Rx thorax : surélévation de la coupole droite
- Echo-hépatique : abcès hépatique
- Sérologie positive

5-Traitement :

Amoebiose infestation:

présence dans les selles de kystes ou de la forme minuta :

@(TILQUINOL / TILBROQUINOL) : 2cp matin et 2cp soir pdt 10 jours

Amoebiose colique :

- METROZAL (metronidazole) 500mg : 1cp x 3/j pdt 7j
- INTETRIX (tilquinol / tilbroquinol) 2cp matin et 2cp soir pdt 10 jours

Amoebiose hépatique:

- METROZAL (metronidazole) 500mg : 1cp x 3/j pdt 10j
- INTETRIX (tilquinol / tilbroquinol) 2cp matin et 2cp soir pdt 10 jours

Refills

Signature

- +)- Ponction drainage de l'abcès

Dr. Kacem Seif.

123 Lorem avenue,
Region, City 1023
Phone 123-456-7890



Maladies Infectieuses

Name

Oxyurose

Address

R_x

Oxyurose

1-Agent infectieux :

Enterobius vermicularis; Nématodes = vers ronds blancs de 10 mm de long

2-Mode de contamination :

voie digestive (portage des mains souillées à la bouche par les enfants)

3-Clinique :

- PRURIT ANAL nocturne ou vespéral, majoré par le grattage**
- Parfois vulvo-vaginite chez la petite fille**
- Récidive fréquente**

4-Diagnostic :

- Présence de vers dans les selles, les sous-vêtements et dans la literie, visibles à l'oeil nu**
- Scotch test le matin sur la marge anale**

5-Traitement :

- VERZOL (albendazole) 400mg cp ou 4% suspension buvable : 1 cp ou 1 cuillère mesure**

-Mesures hygiéno-diététiques :

Changement des sous-vêtements, de la litière et du linge de toilette

Couper les ongles, laver les mains avant les repas

-Traiter tous les membres de la famille

-Refaire une 2ème cure 15 jours après

Refills

Rx. No.

Signature

Name Gynécologie Date _____

Address Salpingite

Rx

* Flagyle cp 500mg. Qsp21jr
1cp 3/jr

* Augmentin cp 1g
3/jr

* Doxycycline cp 100mg
1cp 2/jr

Salpingite



Douleur zone pelvienne



Douleur pendant l'ovulation



Sécrétion vaginale anormale



Saignements menstruels irréguliers



Douleur pendant les rapports sexuels



Ref: _____

Rx No: _____

Signature: _____

Gynécologie

Name

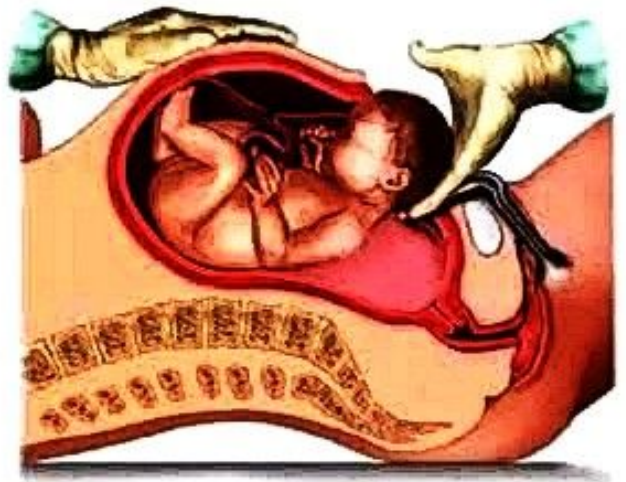
Date

Accouchement par césarienne

Address

Rx

- * Cefacet cp. Qsp 10 jr
1 cp 3/jr
- * Lovenox 0.4 ml inj. Qsp 8jr
1 inj sc a heure fixe
- * trifer fol cp. Qsp 3 mois
1cp 2/jr : 1 mois
1cp 1/jr : 2mois
- * cerazette cp. Qsp 3mois
1 cp le soir a heure fixe
- * Dakin solut. 1 bte
1 app/toilette



Refis

Rx No

Signature

Gynécologie

Name

Date

Avortement en cours

Address

Rx

* Methergin gtt 1 fic
15 gtt 3/jr

* ferro sanol gyn gel 2 bte
1 gel 2/jr

* si : HTA CI de methergin -----> syntocinon

- Avortement inévitable (Fausse-couche en cours)
 - Métrorragies abondantes, parfois état de choc hémorragique.
 - Douleurs pelviennes à type de coliques expulsives.
 - Au spéculum : produit de conception en voie d'expulsion, col bavant.
 - Au TV : col ouvert à son orifice interne.



Refills

Rx No

Signature

Gynécologie

Nome

Date

Fibrome utérin

Address

R_x

Si saignement :

* Orgamétil 2cp 2/jr puis 1cp 2/jr le 2^{eme} cycle du 5 au 25 jr de cycle

* Si CI ----- > duphaston

* Dicynone 1cp 3/jr jusqu'à l'arrêt du saignement

Si absence de saignement :

* Orgamétil 1 cp 2/jr

si malade en préménopause non mariée

* On continue le trtm jusqu'à la ménopause

si malade mariée désirante la grossesse

* Trtm chirurgical conservateur

si non reponse au trtm

* Trtm chirurgical radical



Ref/ls

Rx. No

Signature

Gynécologie

Name

Date

Address

Syndrome grippal

Rx

* Amoxicilline cp1g. Qsp10jr
1cp3/jr

* Doliprane cp 500mg
1cp3/jr

* vit c



Refus

Rx No

Signature

Gynécologie

Name

Date

Address

Accouchement par voie basse

Rx

* Amoxicillin cp. Qsp 10 jr
1 cp 3/jr

* Lovenox 0.4 ml inj. Qsp 8jr
1 inj sc a heure fixe

* trifer fol cp. Qsp 3 mois
1cp 2/jr : 1 mois
1cp 1/jr : 2mois

* cerazette cp. Qsp 3mois
1 cp le soir a heure fixe

* Dakin solut. 1 bte
1 app/toilette



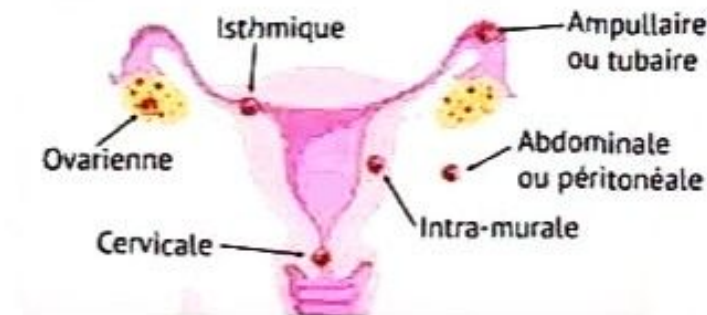
Ref/ls

Rx. No.

Signature

Name Gynécologie Date _____
 Address Grossesse Extra utérine

Rx



- * Methotrexate 1mg/kg à j1 puis 1mg/kg à j5
- * surveillance des taux de bhcg jusqu'a la () à j15
- * si RH (-) ----> injection de l'anti D dans 72h



Ref/la

Rx. No

Signature

Gynécologie

Nome

Date

Menace d'avortement

Address

Rx

* Utrogestan ovule. 1 bte
1 ovule jr la nuit

* Progestérone inj 3 bte
1inj/ jr la 1ere bte
1inj/3jr la 2 eme bte
1inj/semaine la 3 eme bte

Tableaux cliniques

Menace d'avortement

- Métrorragies minimes.
- Douleur pelvienne absente ou de type menstruel.
- Le col est long et fermé.
- La taille de l'utérus correspond à l'âge gestationnel.
- Echographie : Cœur +, LCC en rapport. Parfois : décollement partiel de l'œuf.



Refus

Prescrit

Signature

Gynécologie

Name

Date

Address

Règles abondantes

Rx

* Dicynone cp 1 bte
2 cp 3/jr



* ferro sanol gyn gel. 2 bte
1 gel 2/jr



+ Bilan: BHCG, FNS



Ref:ls

Rx. No

Signature